Abbott

TÚCICLO TÚRITMO

THM					
CÓMO ACTÚAN	EFECTIVIDAD	CUÁNDO INICIAR	MODO / FRECUENCIA DE USO	OPCIONES	BENEFICIOS ADICIONALES
Reposición estrogénica	80%	Acorde a la presencia de síntomas	Un óvulo semanal; el tiempo de uso depende del médico tratante	**Esteine** Estriol en óvulos de liberación controlada 3.5 mg	Uso tópico, absorción sistémica prácticamente nula, solo actúa en receptores beta estrogénicos (locales); mejoría del síndrome genitourinario de la menopausia: favorecimiento de la salud sexual, de la dispareunia, la sequedad vaginal, el riesgo de infecciones urinarias o vaginales.[1]
Reposición estrogénica	90%	Mujer en menopausia, sintomática	28 tabletas 1 tableta diaria, toma contínua	**Segufem** Estradiol Valerato 2mg + Dienogest 2mg	Actividad antiandrogénica; bajo riesgo cardiovascular.[2,3]
Reposición estrogénica	90%	Mujer en menopausia, sintomática	28 tabletas 1 tableta diaria, toma contínua	**Segufem mini** Estradiol Valerato 1mg + Dienogest 2mg	Actividad antiandrogénica; bajo riesgo cardiovascular; menor carga estrogénica.[4]
Reposición estrogénica	90%	Mujer en perimenopausia, sintomática	28 tabletas 1 tableta diaria, toma contínua	**Jex** Drospirenona 2mg y 1mg hemihidrato de estradiol equivalente a 17 beta estradiol	Ayuda a la regularización del sangrado hasta decisión con el médico tratante de ajustes necesarios. Actividad antimineralocorticoide, antiandrogénica; acción anticonceptiva.[5]
Reposición estrogénica	86%	Mujer en menopausia, sintomática	30 tabletas 1 tableta diaria, toma contínua	**Tinox Tibolona** micronizada 2,5mg.	Útil en mujeres que no pueden, usar estrógenos, manejo de síntomas vasomotores bajo riesgo de afectación de la libido, protección ósea.[6]
Reposición estrogénica	90%	Mujer en menopausia, sintomática	28 tabletas 1 tableta diaria, toma contínua	**Femoston Conti** Estradiol hemihidrato eqv. Estradiol 1mg - Didrogesterona 5 mg	Mujeres con útero; bajo riesgo de cáncer de mama, comparado con otros preparados, de cáncer de mama y bajo riesgo cardiovascular; protección ósea.[7,8]
Reposición estrogénica	90%	Mujer en menopausia, sintomática	1 aplicación mensual, inyectable	**Menodin** Hexahidrobenzoato de estradiol 5 mg	Mujeres sin útero, que no requieren progestina adicional.[9]

REFERENCIAS:

1.Steele NM, Ledbetter CA, Bernier F. Genitourinary syndrome of menopause and vaginal estrogen use.Urol Nurs. 2016;36(2):59–65. **2.**Graser T, Muller A, Mellinger U, Muck A.O, Lippert T-H, Oettel M. Continuous-Combined Treatment of the Menopause with Combinations of Oestradiol Valerate and Dienogest — a Dose-Ranging Study. Maturitas 2000;35:253–261. **3.** Dinger J, Minh Heinemann K. Impact of Estrogen Type on Cardiovascular Safety of Combined Oral Contraceptives. Contraception 2016;94:328–339. **4.** Rouskova D, Mittmann K, Schumacher U, Dietrich H, Zimmermann T. Effectiveness, tolerability and acceptance of a low-dosed estradiol/dienogest formulation (Lafamme 1 mg/2 mg) for the treatment of menopausal complaints: a non-interventional observational study over 6 cycles of 28 days. Gynecological Endocrinology. 2015;31(7):560-564. DOI: 10.3109/09513590.2015.1024220 **5.** Palacios S, Foidart JM, Genazzani AR. Advances in hormone replacement therapy with drospirenone, a unique progestogen with aldosterone receptor antagonism. Maturitas. 2006 Nov 20;55(4):297-307. doi: 10.1016/j.maturitas.2006.07.009. Epub 2006 Sep 1. PMID: 16949774. **6.** Cummings SR, Ettinger B, Delmas PD, et al. The effects of tibolone in older postmenopausal women. The New England Journal of Medicine. 2008;359(7):697–708. https://doi.org/10.1056/NEJMoa0800743 **7.** Vinogradova Y, Coupland C, Hippisley-Cox J. Use of hormone replacement therapy and risk of breast cancer: nested case-control studies using the QResearch and CPRD databases. BMJ. 2020 Oct 28;371:m3873. doi: 10.1136/bmj.m3873. PMID: 33115755; PMCID: PMC7592147. **8.** Schneider C, Jick SS, Meier CR. Risk of cardiovascular outcomes in users of estradiol/dydrogesterone or other HRT preparations. Climacteric. 2009;12(5):445-453. **9.** Panay N, Ang SB, Cheshire R, et al. Menopause and MHT in 2024: Addressing the key controversies – an International Menopause Society White Paper. Climacteric. 2024;27(5), 441–457. https://doi.org/10.1080/13697137.2024.2394950

MATERIAL EXCLUSIVO PARA EL CUERPO MÉDICO

Abbott

TÚCICLO TÚRITMO

ESCANEA PARA VER LA INFORMACIÓN COMPLETA DE LOS REGISTROS SANITARIOS DEL VADEMÉCUM DE LA LÍNEA DE SALUD FEMENINA ABBOTT

Esteine®

SEGUFEM®

SEGUFEM® Mini

Jex®

TINOX®

Femoston® conti

MATERIAL EXCLUSIVO PARA EL CUERPO MÉDICO